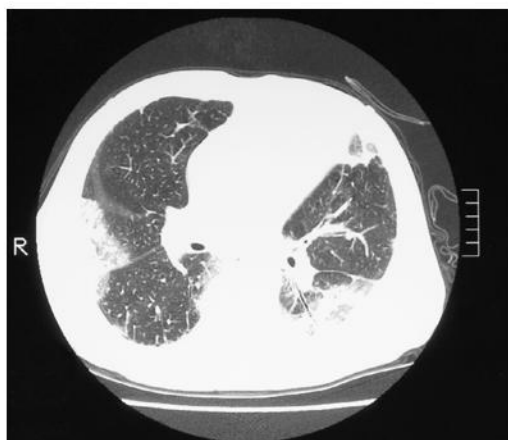
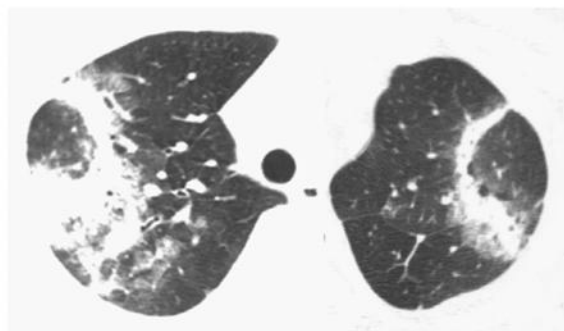




a.



b.



c.

図2 特発性器質性肺炎の胸部X線写真

(a) CT, (b) 両側多発性 consolidation, (c) reversed halo sign

治療と予後

一般に副腎皮質ステロイド薬に対する反応性は良好で、臨床症状や胸部異常影は消失する。prednisoloneを0.5~1 mg/kg/dayから開始し1~2ヵ月維持した後に、2~4週ごとに5 mgずつ減量する³⁾。副腎皮質ステロイド薬に反応不良の場合、免疫抑制薬が併用される。副腎皮質ステロイド薬の減量（特にprednisolone 10 mg/day以下）や中止に伴い高率に再燃する（30~40%）。再燃時にも副腎皮質ステロイド薬は有効で、良好な予後を示す⁵⁾。

進行性、予後不良のCOPの理解

副腎皮質ステロイド薬に対する反応不良例や、急速進行性で致死的な症例が報告される。これらの症例ではOP病変以外に、背景にUIP病変が認められ、実際はIPF/UIPの急性増悪例である可能性や、fibrotic NSIP所見が同時に認められる可能性が指摘されている^{1,2)}。OP病変が吸収されずに瘢痕化し、UIP病変に類似した線維化を呈する症例が報告されているが、COPの一病型とすべきか否か不明瞭である^{3,6)}。

2

急性間質性肺炎

acute interstitial pneumonia (AIP)

到達目標

- ◆急性間質性肺炎（AIP）の病態を説明できる
- ◆AIPの臨床像、検査所見、画像所見が説明でき、鑑別疾患を列挙できる。また、AIPの病状や重症度に応じた治療を行うことができる

病因・病態・疫学

急性間質性肺炎（AIP）は、急速進行性の経過をたどる原因不明の間質性肺炎の開胸肺生検症例の検討から提唱された疾患概念であり、特発性間質性肺炎のひとつに分類される^{3,7)}。2013年の国際分類では、特発性器質性肺炎とともに急性経過を示す病型に分類されている。急性呼吸窮迫症候群（acute respiratory distress syndrome: ARDS）と同様の臨床症状を呈するが、誘因（敗血症、肺感染症、外傷、薬剤など）を認めない点が異なり、idiopathic ARDSとも呼ばれる病態である^{3,7)}。